PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

Posterior da coxa e virilha

O roteiro da fase final e da dor que não passa

Fisioterapia Esportiva e Reabilitação

DUAS MACAS NO DEPARTAMENTO MÉDICO DE UM CLUBE DE FUTEBOL

Parar de tratar quando a dor some, ou tratar sem saber o que se está tratando.

Primeira maca · o meia

posterior de coxa, num sprint

sem dor há uma semana

quer jogar domingo

Segunda maca · o lateral

dor na virilha há dois meses



a maior parte dos dados é do futebol, e isso limita

Dois roteiros, três passos cada

Posterior da coxa, fase final

1. o que já está resolvido → 2. expor à velocidade antes do jogo → 3. critérios de retorno

Virilha

1. dar nome: “pubalgia” não é diagnóstico → 2. medir → 3. tratar com carga

O que o módulo de lesões já resolveu

Exercício em alongamento

o músculo trabalhando alongado encurta o retorno

feito no módulo de lesões

Desconforto tolerável

não atrasa a liberação; preserva força e comprimento de fibra

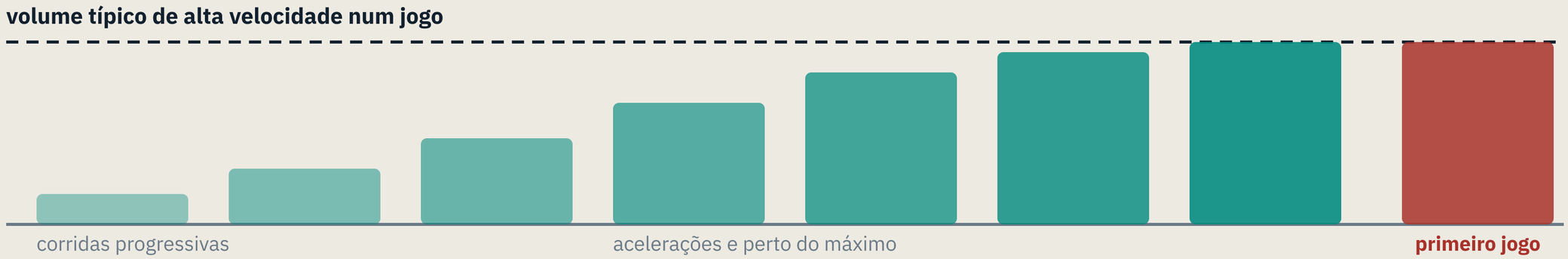
Em aberto

do exercício na maca ao sprint do jogo, e os critérios da volta

o assunto desta conversa

Ensaio australiano, J Orthop Sports Phys Ther 2020

Expor à velocidade antes do jogo



Semanas com corrida de alta velocidade acima do habitual se associaram a mais lesão na semana seguinte, no futebol australiano. O pico é o risco.

Esquema, sem valores medidos · Br J Sports Med 2016

58 especialistas, 28 centros da FIFA

Palpação ✓

sem dor ao apertar o músculo

Força e flexibilidade ✓

sem dor nos testes

Desempenho funcional ✓

sem dor durante e depois, corrida e gesto incluídos

Ressonância ✗

fora: a imagem inicial não prediz a nova lesão

> Sem consenso sobre força excêntrica como critério obrigatório. Decisão compartilhada, com o jogador.

Consenso Delphi, Br J Sports Med 2017

O primeiro sprint máximo não pode ser no jogo.

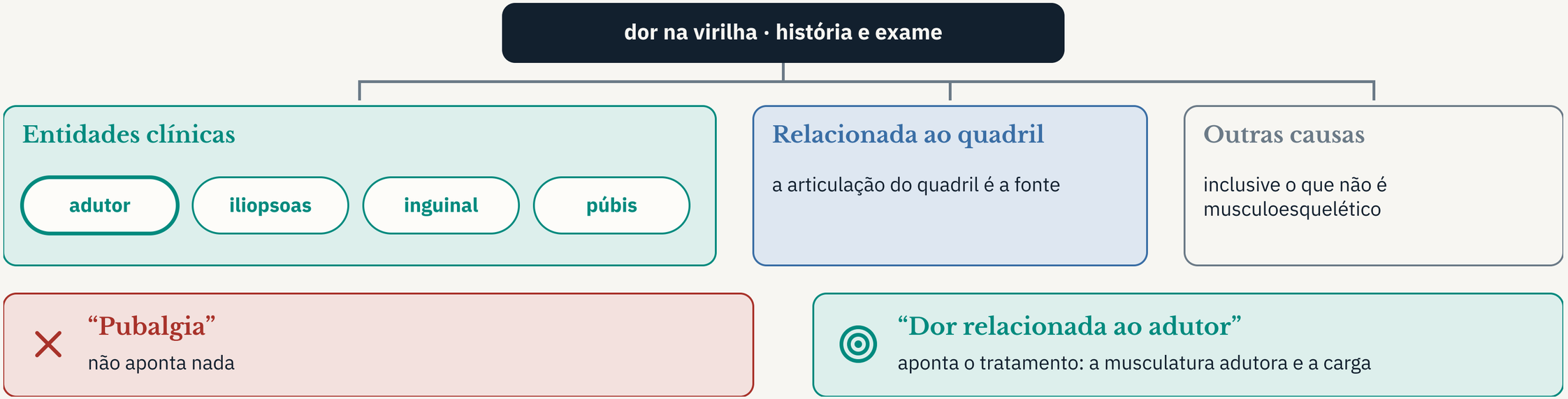
sem dor há uma semana

necessário, não suficiente

- **quantas vezes já correu perto do máximo?**
- **em quantas sessões?**
- **como estava o músculo no dia seguinte?**

só depois, o jogo

Dar nome: a classificação de Doha



24 especialistas de 14 países · Br J Sports Med 2015

Medir, porque a sensação engana

Aperto de adução



dinamômetro ou esfigmomanômetro dobrado

força e dor no esforço · sempre na mesma posição

Questionário de quadril e virilha

37 perguntas, seis domínios

dor	sintomas	dia a dia
esporte	participação	qualidade de vida

a perspectiva do atleta

> “Está melhorando?” deixa de depender de como foi o último treino.

Copenhague, Br J Sports Med 2011

Tratar com carga: o ensaio de 1999

23



treino ativo de força e coordenação da pelve

4



fisioterapia sem treino ativo, recursos passivos

> Dor relacionada ao adutor de longa duração: o que muda o desfecho é a carga, não o recurso passivo.

Ensaio dinamarquês sorteado, Lancet 1999

DEPOIS QUE ELE VOLTAR

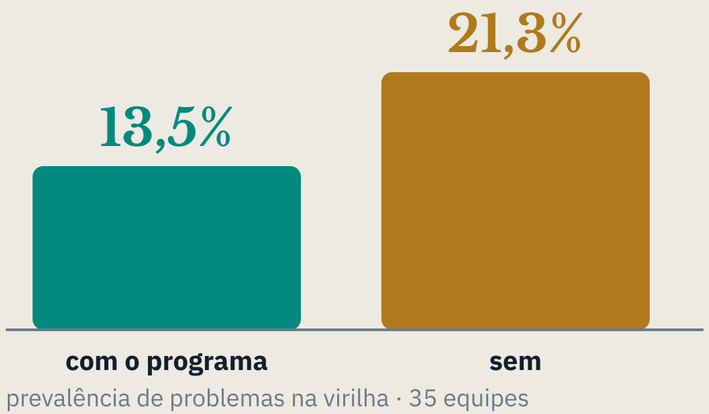
Um exercício de adutores, uma vez por semana

Um exercício de adutores

pré-temporada · 3× por semana

temporada · 1× por semana

a dose que sobrevive ao calendário



prevalência de problemas na virilha · 35 equipes

−41%

risco de relatar problema na virilha

Futebol masculino norueguês, 35 equipes semiprofissionais sorteadas · Br J Sports Med 2019

Quatro armadilhas

“Pubalgia”

tratar sem saber a fonte

Repouso e volta igual

a dor some e volta junto com a carga

Passivo antes da carga

recurso ou injeção como tratamento principal

Esquecer a manutenção

a recidiva mora na volta sem exercícios

POSTERIOR DA COXA E VIRILHA

A última fase é a que evita a próxima lesão

- Posterior: velocidade em degraus e critérios de dor e função, sem ressonância
- Virilha: nome pela classificação de Doha, medida e carga ativa
- Os dois: manutenção na temporada

Médico

Dá o nome e descarta outras causas.

Fisioterapia

Conduz a carga e mede.

Preparação física

Constrói a velocidade e mantém o programa.

Próxima aula: o tornozelo, a região mais lesionada e a que mais recidiva.